فصل ۳

بیماری‌های پالپ و پری‌اپیکال

۱ـ در مورد پالپیت برگشت‌پذیر گزینه صحیح را مشخص کنید؟

الف) معمولاً این دندانها به تحریکات گرمایی پاسخ شدیدتری نسبت به سرما می‌دهند.

ب) این دندانها به دق حساسیت ندارند.

ج) در صورتیکه دندان فاقد پوسیدگی، شکستگی، ترمیم معیوب باشد باید حساسیت عاجی در نظر گرفته شود

د) دندان به الکتریکال پالپ تست در شدت جریان کمتری پاسخ می‌دهد

پاسخ: الف

در پالپیت برگشت پذیر دندان در پاسخ به تحریکات گرمایی درد خفیف تا متوسط کوتاه مدتی را نشان می‌دهد اما پاسخ دندان به تحریکات سرمایی شدیدتر است لقی و حساسیت به دق دیده نمی‌شود و دندان به تست الکتریکی در جریان پایین‌تری پاسخ می‌دهد. اگر علائمی از پوسیدگی و شکستگی و ترمیم معیوب وجود نداشته باشد و عاج اکسپوز شده وجود داشته باشد باید حساسیت عاجی مدنظر قرار گیرد.

۲ـ اگر دردی مشابه علائم پالپیت برگشت پذیر در هنگام جویدن ایجاد شود کدام مورد را باید در نظر گرفت؟

الف) دندان ترک خورده

ب) ترمیم معیوب

ج) حساسیت عاجی

د) الف و ب

پاسخ: د

در صورتیکه علائم مشابه پالپیت برگشت پذیر حین جویدن ایجاد شود معمولاً یک cracked tooth یا یک ترمیم معیوب وجود دارد.

۳ـ گزینه صحیح در مورد پالپیت برگشت ناپذیر کدام است؟

الف) معمولاً درد با راه رفتن تشدید می‌شود.

ب) در مراحل پیشرفته گرما شدت درد را زیاد می‌کند اما سرما اثر تسکین دهنده دارد.

ج) حساسیت به دق در مراحل پیشرفته آن وجود دارد.

د) در مراحل پیشرفته دندان به تست الکتریکی پالپ در درجات پائین پاسخ می‌دهد.

پاسخ: ب

در مراحل اولیه پالپیت برگشت ناپذیر درد شدید بعد از محرک‌های حرارتی دیده می‌شود. درد خود بخودی و مداوم و دردی که هنگام دراز کشیدن زیاد می‌شود از مشخصات آن است. دندان به تست الکتریکی پالپ در درجات پائین‌تر پاسخ می‌دهد. در مراحل بعدی درد ضربان دار که با سرما تسکین می‌یابد دیده می‌شود لقی و حساسیت به دق وجود ندارد و دندان به تست الکتریکی پالپ در جریانهای بالاتر پاسخ می‌دهد و یا اصلا پاسخ نمی‌دهد.

۴ـ همه موارد زیر در مورد پالپ نکروزه صحیح است بجز :

الف) به تست الکتریکی پالپ جواب نمی‌دهد.

ب) به تحریکات گرمایی بصورت شدید پاسخ می‌دهد.

ج) ممکن است بدون علامت باشد.

د) گاهی حساسیت در موقع گاز گرفتن دیده می‌شود.

پاسخ: ب

پالپ نکروز به تست الکتریکی و تحریکات گرمایی پاسخ نمی‌دهد. طیف علائم آن گسترده و متغیر است ممکن است بدون علامت باشد و یا درد حاد وجود داشته باشد. در حین گاز گرفتن ممکن است حساسیت داشته باشد یا نه.

۵ـ در مورد pulp polyp گزینه نادرست کدام است؟

الف) درد شدید خود بخودی در این دندانها دیده می‌شود.

ب) اگر آپکس دندان باز باشد احتمال نکروز پالپ کم‌تر می‌شود.

ج) در دندانهای مولر شایعتر است.

د) در اثر تحریکات مکانیکی و یا تهاجم باکتریال ایجاد می‌شود.

پاسخ: الف

پولیپ پالپ در کودکان و بالغین جوان و دندانهای مولر شیری و دائمی شایعتر است. تحریک مکانیکی و یا تهاجم باکتریال با ایجاد التهاب مزمن سبب ایجاد بافت جوانه‌ای هیپرپلاستیک در این دندانها می‌شوند. این دندانها معمولا بدون علامت‌اند مگر حین جویدن که ممکن است کمی احساس فشار وجود داشته باشد.

۶ـ در بررسی میکروسکوپی pulp polyp کدام مورد دیده نمی‌شود؟

الف) اتافک پالپ با یک بافت جوانه‌ای شبیه پیوژنیک گرانولوما پر شده است.

ب) اپی تلیوم سطح پولیپ ممکن است از اپی تلیوم تفلس یافته در دهان منشأ گرفته باشد.

ج) کلسیفیکاسیون پالپی در این دندانها شایع است.

د) قسمت اپیکالی پالپ در این دندانها معمولاً نکروتیک است.

پاسخ: د

پولیپ پالپ از یک بافت جوانه‌ای شبیه پیوژنیک گرانولوما تشکیل شده است که با اپی تلیوم سنگفرشی مطبق منشأ گرفته از لثه مجاور و یا اپی تلیوم تفلس یافته در دهان پوشیده شده است. کلسیفیکاسیون در این دندانها شایع بوده و فیبروز و التهاب مزمن در پالپ دیده می‌شود اما قسمت اپیکالی پالپ معمولاً طبیعی است و یا التهاب و فیبروز کمی دارد.

CamScanner

۷ـ مشاهده نواحی کانونی از نکروز که حاوی لکوسیت‌های PMN و هیستیوسیت‌ها بوده و از اطراف با بافت پالپی فیبروز و ارتشاح لنفوسیت و پلاسماسل احاطه شده است در نمای میکروسکوپی کدام ضایعه دیده می‌شود؟

الف) پالپیت برگشت پذیر

ب) پالپیت برگشت ناپذیر

ج) پولیپ پالپ

د) نکروز پالپی

پاسخ: ب

۸ـ در مورد دردهای پالپی کدام گزینه صحیح است؟

الف) دردهای پالپی معمولاً میدلاین را قطع می‌کنند اما به قوس دیگر منتقل نمی‌شوند.

ب) دردهای پالپی میدلاین را قطع نمی‌کنند اما به قوس دیگر منتقل می‌شوند.

ج) دردهای پالپی فقط کوادرانت درگیر را متأثر می‌کنند.

د) دردهای پالپی علاوه بر قطع میدلاین می‌توانند به قوس دیگر هم منتقل شوند.

پاسخ: ب

۹ـ کدام مورد عاج اولیه را به درستی تعریف می‌کند؟

الف) عاجی که قبل از اتمام شکل‌گیری ریشه تشکیل می‌شود.

ب) عاجی که قبل از اتمام شکل‌گیری تاج تشکیل می‌شود.

ج) عاجی که تا زمان تشکیل ۱/۳ طول ریشه تشکیل می‌شود.

د) عاجی که تا زمان شروع رویش دندان شکل می‌گیرد.

پاسخ: ب

۱۰ـ در progeria تشکیل وسیع و زودهنگام کدام نوع عاج دیده می‌شود؟

الف) عاج واکنشی **ب) عاج ترمیمی**

ج) عاج ثانویه **د) عاج اسکلروزه**

پاسخ: ج

۱۱ـ انسداد اتاقک و کانالهای پالپ دندان به دنبال آسیب تروماتیک باعث تشکیل کدام یک می‌شود؟

الف) عاج واکنشی

ب) کلسیفیکاسیون متاستاتیک

ج) کلسیفیکاسیون متامورفوزیس

د) عاج ترمیمی

پاسخ: ج

۱۲ـ گزینه نادرست در مورد عاج ثانویه کدام است؟

الف) مقدار عاج ثانویه در دندانهای نهفته کمتر از دندانهای رویش یافته است.

ب) رسوب عاج ثانویه در مردان بیشتر است.

ج) در دندانهای نهفته رسوب عاج ثانویه از ناحیه اپیکال و در دندانهای رویش یافته از ناحیه تاجی دندان است.

د) کمترین میزان رسوب عاج در کف پالپ است.

پاسخ: د

بیشترین رسوب عاج در کف پالپ و بعد در سقف پالپ است. حداقل رسوب عاج در دیواره‌های جانبی پالپ است بدین صورت ارتفاع پالپ چمبر کم می‌شود اما پهنای آن به مقدار کمی کاهش می‌یابد.

۱۳ـ تولید عاج ثانویه فیزیولوژیک با همه موارد زیر مرتبط است بجز:

الف) نقرس

ب) سنگ کلیه

ج) فشارخون بالا

د) دنتین دیس پلازی I

پاسخ: د

تولید عاج ثانویه فیزیولوژیک بسیار به افزایش سن وابسته است اما با برخی بیماریها مثل آرتریت، نقرس، سنگ کلیه، سنگ صفراوی، آترواسکلروز و فشارخون بالا نیز رابطه دارد.

۱۴ـ گزینه نادرست در مورد عاج واکنشی کدام است؟

الف) توسط ادنتوبلاست‌های جدید ساخته می‌شود.

ب) توبول‌های آن در امتداد عاج اولیه و ثانویه‌اند.

ج) نمای نامنظم‌تری نسبت به عاج اولیه دارد.

د) در پاسخ به تحریک خفیف تا متوسط ساخته می‌شود.

پاسخ: الف

عاج واکنشی توسط ادنتوبلاست‌های باقیمانده ساخته می‌شود.

۱۵ـ گزینه نادرست در مورد عاج ترمیمی کدام است؟

الف) در پاسخ به محرک‌های شدیدتر ساخته می‌شود.

ب) از ادنتو بلاست‌های منشأ گرفته از سلولهای تمایز نیافته پالپ ساخته می‌شود.

ج) بصورت عاج نامنظم با توبولهای سازمان نیافته است.

د) سرعت تشکیل آن آهسته‌تر از عاج واکنشی است.

پاسخ: د

عاج واکنشی با سرعت آهسته اما عاج ترمیمی بسیار سریعتر ساخته می‌شود.

۱۶ـ در مورد Interface detain (Fibrodentin) گزینه نادرست کدام است؟

الف) لایه اول عاج واکنشی است.

ب) لایه اول عاج ترمیمی است.

ج) فاقد توبول است.

د) بدون سلول و یا حاوی انکلوزیونهای پراکنده هسته‌ای می‌باشد.

پاسخ: الف

۱۷ـ کدام فاکتور رشدی به دنبال آسیب عاجی آزاد شده و تمایز ادنتوبلاست‌های نسل دوم را تحریک می‌کنند؟

الف) $TGF\alpha$ **ب) TGF_B**

ج) FGF_3 **د) VEGF**

پاسخ: ب

۱۸ـ همه موارد زیر باعث افزایش کلسیفیکاسیونهای پالپ می‌شوند بجز:

الف) مکمل‌های فلوراید

ب) دنتین دیس پلازی نوع Ib

CamScanner

ج) سن

د) افزایش ویتامین D

پاسخ: ب

افزایش سن، مصرف مکمل‌های فلوراید، هایپر ویتامینوز D و دنتین دیس پلازی نوع II با کلسیفیکاسیونهای پالپ مرتبط‌اند.

۱۹ـ کلسیفیکاسیون پالپ در همه بیماریهای زیر دیده می‌شود بجز:

الف) Calcinosis universalis

ب) Ehlers – Danlos Syndrome

ج) Pulpal dysplasia

د) Maltiple hamartoma syndrome

پاسخ: د

در Dentin dysplasia II و Dantin dysplasia Id و pulpal dysplasia و Tumoral calcinosis و Calcinosis universalis و سندرم اهلرز دانلوس و مراحل نهایی بیماری کلیوی افزایش کلسیفیکاسیونهای پالپی دیده می‌شود.

۲۰ـ گزینه نادرست در مورد مراحل ابتدایی عفونت پری اپیکال کدام است؟

الف) به مرحله ابتدایی عفونت پری اپیکال، پریودنتیت اپیکالی حاد گفته می‌شود.

ب) سلولهای التهابی غالب در این مرحله ماست سل‌ها هستند.

ج) پروستاگلاندین‌های آزاد شده از سلولهای التهابی با فعال کردن استئوکلاست‌ها باعث تحلیل استخوان می‌شوند.

د) تحلیل استخوان در پیشگیری از انتشار عفونت نقش دارد.

پاسخ: ب

سلولهای التهابی غالب در این مرحله نوتروفیل‌ها هستند که با ترشح پروستا گلاندین‌ها و فعال کردن استئوکلاست‌ها و تحلیل استخوان اطراف فضایی برای تجمع سلولهای دفاعی بر علیه عفونت فراهم می‌کنند

۲۱ـ کدام مورد به نقش لنفوسیت‌ها در فرآیند التهاب ناحیه پری اپیکال اشاره می‌کند؟

الف) توقف فعالیت استئوکلاست‌ها

ب) تحریک فیبروبلاست‌ها

ج) تحریک عروق خونی

د) همه موارد

پاسخ: د

۲۲ـ کدام گزینه آبسه Phoneix را به درستی توصیف می‌نماید؟

الف) التهاب حاد ثانویه در یک آبسه پری اپیکال

ب) التهاب حاد ثانویه در یک گرانولوم پری اپیکال

ج) آبسه ایجاد شده در یک دندان با پالپیت برگشت ناپذیر

د) التهاب حاد ثانویه در یک استئومیلیت

پاسخ: ب

۲۳ـ در مورد کلسیفیکاسیونهای پالپی گزینه نادرست را مشخص کنید؟

الف) دنتیکل‌ها در نتیجه کلسیفیکاسیون در اطراف یک کانون مرکزی (مانند کلاژن، بقایای سلولی و...) بوجود می‌آیند.

ب) کلسیفیکاسیونهای خطی منتشر اغلب موازی عروق و اعصاب دیده می‌شوند.

ج) دنتیکل‌ها و سنگ‌های پالپی می‌توانند در رادیوگرافی قابل مشاهده گردند.

د) کلسیفیکاسیونهای پالپی معمولاً با تغییرات بالینی مهمی همراه نمی‌باشند.

پاسخ: الف

دنتیکل‌های در نتیجه واکنش متقابل اپی تلیو مزانشیمال ایجاد می‌شوند.

۲۴ـ شایعترین ضایعه التهابی پری اپیکال کدام است؟

الف) کیست پری اپیکال

ب) گرانولوم پری اپیکال

ج) آبسه پری اپیکال

د) سلولیت

پاسخ: ب

۲۵ـ گزینه نادرست در مورد نمای میکروسکوپی پری اپیکال گرانولوما کدام است؟

الف) پیرونین بادی که بصورت تجمعات بازوفیل مشاهده می‌شود اختصاصی پری اپیکال گرانولوما می‌باشد .

ب) کلسترول می‌تواند با جذب ماکروفاژها و ژانت سل‌های جسم خارجی در غیاب عفونت میکروبی باعث تداوم التهاب در ناحیه شود.

ج) شایعترین سلول التهابی در پری اپیکال گرانولوما لنفوسیت می‌باشد.

د) بقایای اپی تلیالی مالاسز ممکن است در پری اپیکال گرانولوما مشاهده شوند.

پاسخ: الف

پری اپیکال گرانولوما از یک بافت جوانه‌ای التهابی که توسط یک دیواره همبندی فیبروزه محدود شده تشکیل شده است. ارتشاح التهابی آن شامل لنفوسیت‌ها به همراه نوتروفیل، پلاسماسل، هیستیوسیت و گاهی ماستسل و ائوزینوفیل است. راسل بادی (گلبولهای ائوزینوفیل از جنس گاما گلوبولین) و پیرونین بادی (تجمعات بازوفیل) که هر دو از محصولات پلاسما سل‌ها هستند ممکن است در آن دیده شوند (این محصولات اختصاصی پری اپیکال گرانولوما نیستند). بقایای اپی تلیالی مالاسز، کلسترول کلفت، ژانت سل، نواحی خروج RBC از عروق و رسوب هموسیدرین هم ممکن است دیده شود. شکافهای کلسترول در نواحی با التهاب طولانی مدت دیده می‌شوند و می‌توانند با جذب ماکروفاژها و ژانت سلهای جسم خارجی باعث تداوم التهاب حتی در غیاب عفونت شوند.

۲۶ـ در مورد Fibrous periapical scars گزینه نادرست کدام است؟

الف) در این ضایعات نقایص پری اپیکال بجای استخوان با بافت کلاژنه متراکم پر شده‌اند.

ب) معمولاً وقتی هر دو صفحه کورتیکال فاسیال و لینگوال از بین رفته باشند ایجاد می‌شوند.

ج) ممکن است در صفحات کورتیکالی دست نخورده هم ایجاد شوند.

د) بایستی با جراحی برداشته شوند.

پاسخ: د

این اسکارها نیازی به برداشت جراحی در آینده ندارند.

۲۷ـ کدام مورد نمی‌تواند منشأ اپی تلیوم کیست پری اپیکال باشد؟

CamScanner

الف) اپی تلیوم پوشاننده فیستول
ب) اپی تلیوم پوشش سینوس
ج) اپی تلیوم شیار لثه
د) اپی تلیوم متفلس شده در دهان

پاسخ: د

منشأ اپی تلیوم کیست معمولاً بقایای اپی تلیالی مالاسز است اما اپی تلیوم شیار لثه، سینوس و فیستول هم می‌توانند منشأ پوشش کیست باشند.

۲۸ـ کدام یک از انواع کیست‌ها پوشش اپی تلیالی کاملی ندارد؟
الف) Periapical pocket cysts
ب) Periapical true cysts
ج) Lateral radicular cysts
د) Residual periapical cysts

پاسخ: الف

در کیست‌های پری اپیکال پاکتی بعلت اینکه بخش اپیکالی ریشه داخل لومن کیست قرار دارد پوشش اپی تلیالی کاملی دیده نمی‌شود.

۲۹ـ در مورد کیست‌های پری اپیکال گزینه نادرست را مشخص نمائید؟
الف) بعد از جراحی آزمایش هیستوپاتولوژی دقیق برای افتراق کیست پری اپیکال true از Pocket ضرورت دارد .
ب) علت افزایش اندازه کیست‌های پری اپیکال تفلس اپی تلیوم به داخل لومن است.
ج) معمولاً در کیست‌های پری اپیکال residual اندازه کیست با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند.
د) کیست‌های رادیکولار Lateral در نمای رادیوگرافی مشابه کیست‌های لترال پریودنتال می‌باشند.

پاسخ: الف

از نظر تئوری با تفلس اپی تلیوم به داخل لومن در کیست پری اپیکال، محتوای پروتئینی لومن زیاد شده و برای متعادل شدن فشار اسمزی مایع از بافت همبندی اطراف وارد لومن می‌شود و در نتیجه کیست بزرگ می‌شود. بعد از جراحی بررسی میکروسکوپی دقیق به منظور افتراق کیست پری اپیکال حقیقی از کاذب اثری روی درمان بیمار نداشته و غیرضروری است.

۳۰ـ در کدام نوع کیست امکان مشاهده رادیو اپیستی‌هایی در قسمت مرکزی لومن وجود دارد؟
الف) Periapical pocket cysts
ب) Periapical true cysts
ج) Lateral radicular cysts
د) Residual periapical cysts

پاسخ: د

در کیست residual ممکن است با گذشت زمان اجزا سلولی داخل لومن دژنره و دچار کلسیفیکاسیون دیستروفیک شده در نتیجه رادیواپیستی‌هایی در لومن مشاهده شود.

۳۱ـ کدام گزینه خصوصیات رادیوگرافی کیست پری اپیکال را به درستی بیان نمی‌کند؟
الف) باعث از بین رفتن لامینا دورا می‌شود.
ب) تحلیل ریشه شایع است.
ج) جابه جایی دندانهای مجاور دیده نمی‌شود.
د) می‌تواند باعث تورم شود.

پاسخ: ج

کیست پری اپیکال می‌تواند باعث جابجایی دندانهای مجاور شود.

۳۲ـ امکان مشاهده اپی تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژک‌دار در کدام کیست وجود دارد؟
الف) کیست پری اپیکال
ب) کیست دنتی ژروس
ج) کیست نازولبیال
د) هر سه مورد

پاسخ: د

۳۳- کدام مورد نمونه‌ای از prosoplasia می‌باشد؟
الف) مشاهده راشتون بادی در پوشش اپی تلیالی کیست پری اپیکال
ب) مشاهده pulse granuloma در دیواره کیست پری اپیکال
ج) مشاهده Exocytosis در پوشش اپی تلیالی کیست پری اپیکال
د) مشاهده اپی تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب در پوشش اپی تلیالی کیست پری اپیکال

پاسخ: د

اپی تلیوم ادنتوژنیک توانایی نشان دادن تمایزهای اختصاصی مثل تبدیل به اپی تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب دارد. (Prosoplasia)

۳۴ـ مشاهده Rushton bodies از خصوصیات کدام ضایعه است؟
الف) کیست پری اپیکال
ب) گرانولومای پری اپیکال
ج) آبسه پری اپیکال
د) سلولیت

پاسخ: الف

راشتون بادی به نواحی کلسیفیکاسیون خطی یا هلالی شکل در پوشش اپی تلیالی کیست رادیکولار اطلاق می‌شود.

۳۵ـ کدام مورد در بررسی میکروسکوپی پوشش اپی تلیالی کیست پری اپیکال دیده نمی‌شود؟
الف) Exocytosis
ب) Spongiosis
ج) Hyperplasia
د) Keratinized epithelium

پاسخ: د

پوشش اپی تلیالی کیست پری اپیکال سنگفرشی مطبق است که ممکن است نواحی از exocytosis (ورود سلولهای التهابی به داخل اپی تلیوم)، Spongiosis و هیپرپلازی هم در آن دیده شود. همچنین نواحی از سلولهای موکوسی و اپی تلیوم استوانه‌ای مطبق کاذب مژک‌دار هم می‌توانند در این کیست (و کیست دنتی ژروس) دیده شود.

۳۶ـ همه موارد زیر در دیواره کیست پری اپیکال دیده می‌شوند بجز:
الف) کلسترول کلفت
ب) راشتون بادی
ج) pulse granuloma
د) راسل بادی

پاسخ: ب

راشتون بادی در پوشش اپی تلیالی کیست رادیکولار ممکن است دیده شود (نه در دیواره کیست). pulse granuloma به صورت نواحی کوچک ائوزینوفیل که از اطراف با کلاژن متراکم و چین خورده محدود شده‌اند می‌باشد. این اجسام از اگزودای التهابی خارج شده از عروق منشأ گرفته‌اند که دچار فیبروز و کلسیفیکاسیون شده‌اند و در هر ناحیه با التهاب مزمن داخل استخوانی ممکن است دیده شوند. راسل بادی نیز از محصولات پلاسماسلی و در هر ناحیه که پلاسماسل ها تجمع یافته باشند می‌تواند دیده شود.

CamScanner

۳۷ـ کدام گزینه Pulse granuloma را به درستی توصیف می‌نماید؟

الف) نواحی کوچک از ماده ائوزینوفیل که از اطراف با الیاف کلاژن و سلولهای التهابی محدود شده است.

ب) گلبولهای ائوزینوفیل از جنس گاما گلوبولین

ج) قطعات بازوفیل از محصولات پلاسماسلی

د) کلسیفیکاسیونهای خطی یا هلالی بازوفیل

پاسخ: الف

گزینه ب راسل بادی، گزینه ج پیرونین بادی و گزینه د راشتون بادی را توصیف می‌نماید.

۳۸ـ کدام گزینه در مورد آبسه پری اپیکال صحیح نمی‌باشد؟

الف) در مراحل اولیه آبسه اعمال فشار باعث کاهش حساسیت دندان می‌شود.

ب) با پیشرفت ضایعه، حساسیت به دق و بیرون زدگی دندان دیده می‌شود.

ج) در اکثر موارد این دندانها رادیولوسنسی وسیع در ناحیه اپیکال نشان می‌دهند.

د) پارولیس از بافت جوانه‌ای التهابی تشکیل شده است.

پاسخ: ج

معمولاً این دندانها تغییر رادیوگرافی زیادی نشان نمی‌دهند چرا که فرصت کافی برای تخریب استخوان و ایجاد رادیولوسنسی وجود نداشته است.

۳۹ـ همه آبسه‌های دندانی زیر از سمت لینگوال پرفوره می‌شوند بجز:

الف) لترال max

ب) مولر دوم man

ج) ریشه پالاتال مولرهای Max

د) سنترال Max

پاسخ: د

به جز لترال max و مولر دوم و سوم Man و ریشه پالاتال مولرهای Max، بقیه آبسه‌های دندانی از سمت باکال پرفوره می‌شوند.

۴۰ـ در صورت باقی ماندن سینوس ترکت بعد از درمان دندان چه باید کرد؟

الف) نیازی به درمان وجود ندارد

ب) مصرف آنتی بیوتیک

ج) جراحی و کورتاژ ترکت

د) درمان مجدد اندو

پاسخ: ج

معمولاً سینوس ترکت بطور خودبخودی از بین می‌رود اما اگر باقی بماند جراحی و کورتاژ لازم است.

۴۱ـ Woody Tongue از علائم کدام بیماری بوده و به چه علت ایجاد می‌شود؟

الف) آنژین لودویگ ـ درگیری فضای تحت فکی

ب) ترومبوز سینوس کاورنوس ـ درگیری عضلات جونده

ج) آنژین لودویگ ـ درگیری فضای زیر زبانی

د) ترومبوز سینوس کاورنوس ـ درگیری فضای زیر زبانی

پاسخ: ج

۴۲ـ نمای Bull neck به چه علت ایجاد می‌شود؟

الف) انتشار عفونت به فضای تحت فکی در آنژین لودویگ

ب) انتشار عفونت به فضای زیر زبانی و فضای حلقی طرفی در ترومبوز سینوس کاورنوس

ج) انتشار عفونت به فضای حلقی طرفی و پشت حلقی در آنژین لودویگ

د) انتشار عفونت به فضای تحت فکی در ترومبوز سینوس کاورنوس

پاسخ: الف

۴۳ـ درگیری کدام فضا در ترومبوز سینوس کاورنوس دیده نمی‌شود؟

الف) فضای کانین ب) فضای باکال

ج) فضای اینفراتمپورال د) فضای زیر زبانی

پاسخ: د

۴۴ـ در درمان آنژین لودویگ اولویت نخست کدام است؟

الف) حذف کانون عفونت

ب) آنتی بیوتیک تراپی

ج) اینسیژن و درناژ

د) باز نگه داشتن راه هوایی

پاسخ: د

۴۵ـ علت استئومیلیت چرکی در کشورهای توسعه یافته اکثراً چه می‌باشد؟

الف) عفونت ادنتوژنیک ب) شکستگی فک

ج) ANUG د) الف و ب

پاسخ: د

۴۶ـ کدام یک جزء عوامل مستعدکننده استئومیلیت چرکی نمی‌باشد؟

الف) آنمی سلول داسی

ب) پاژت

ج) سمنتو اسئوس دیس پلازی

د) استئوپروزیس

پاسخ: د

مصرف تنباکو، الکل، مواد مخدر وریدی، دیابت، تب اگزانتماتوز، مالاریا، آنمی سلول داسی، سوء تغذیه، بدخیمی، بیماری کلاژن واسکولار، ایدز، پرتوتالی، استئوپتروز، دیس استئواسکلروز، پاژت و سمنتواسئوس دیس پلازی از عوامل مستعدکننده استئومیلیت چرکی‌اند.

۴۷ـ کدام گزینه از عوامل مستعدکننده درگیری فک بالا در استئومیلیت نمی‌باشد؟

الف) سن کم ب) ANUG

ج) نوما د) جنس مذکر

پاسخ: د

۴۸ـ مشاهده نواحی رادیولوسنت ragged و patchy با حدود نامشخص همراه با سکسترهای رادیواپک در مرکز ضایعه به نفع کدام نوع استئومیلیت می‌باشد؟

الف) Chronic suppurative osteomyelitis

ب) Diffuse Sclerosing osteomyelitis

ج) Acute Suppurative osteomyelitis

د) Focal Sclerosing osteomyelitis

پاسخ: الف

در استئومیلیت حاد چرکی ممکن است تغییرات رادیوگرافی مشاهده نشود و یا لوسنسی با حدود نامشخص دیده شود. در استئومیلیت اسکلروزه منتشر افزایش رادیودنسیتی در نواحی با التهاب مزمن مثل پریودنتیت یا بیماری التهابی پری اپیکال

CamScanner

۳۷ـ کدام گزینه Pulse granuloma را به درستی توصیف می‌نماید؟

الف) نواحی کوچک از ماده ائوزینوفیل که از اطراف با الیاف کلاژن و سلولهای التهابی محدود شده است.

ب) گلبولهای ائوزینوفیل از جنس گاما گلوبولین

ج) قطعات بازوفیل از محصولات پلاسماسلی

د) کلسیفیکاسیونهای خطی یا هلالی بازوفیل

پاسخ: الف

گزینه ب راسل بادی، گزینه ج پیرونین بادی و گزینه د راشتون بادی را توصیف می‌نماید.

۳۸ـ کدام گزینه در مورد آبسه پری اپیکال صحیح نمی‌باشد؟

الف) در مراحل اولیه آبسه اعمال فشار باعث کاهش حساسیت دندان می‌شود.

ب) با پیشرفت ضایعه، حساسیت به دق و بیرون زدگی دندان دیده می‌شود.

ج) در اکثر موارد این دندانها رادیولوسنسی وسیع در ناحیه اپیکال نشان می‌دهند.

د) پارولیس از بافت جوانه‌ای التهابی تشکیل شده است.

پاسخ: ج

معمولاً این دندانها تغییر رادیوگرافی زیادی نشان نمی‌دهند چرا که فرصت کافی برای تخریب استخوان و ایجاد رادیولوسنسی وجود نداشته است.

۳۹ـ همه آبسه‌های دندانی زیر از سمت لینگوال پرفوره می‌شوند بجز:

الف) لترال max

ب) مولر دوم man

ج) ریشه پالاتال مولرهای Max

د) سنترال Max

پاسخ: د

به جز لترال max و مولر دوم و سوم Man و ریشه پالاتال مولرهای Max، بقیه آبسه‌های دندانی از سمت باکال پرفوره می‌شوند.

۴۰ـ در صورت باقی ماندن سینوس ترکت بعد از درمان دندان چه باید کرد؟

الف) نیازی به درمان وجود ندارد

ب) مصرف آنتی بیوتیک

ج) جراحی و کورتاژ ترکت

د) درمان مجدد اندو

پاسخ: ج

معمولاً سینوس ترکت بطور خودبخودی از بین می‌رود اما اگر باقی بماند جراحی و کورتاژ لازم است.

۴۱ـ Woody Tongue از علائم کدام بیماری بوده و به چه علت ایجاد می‌شود؟

الف) آنژین لودویگ ـ درگیری فضای تحت فکی

ب) ترومبوز سینوس کاورنوس ـ درگیری عضلات جونده

ج) آنژین لودویگ ـ درگیری فضای زیر زبانی

د) ترومبوز سینوس کاورنوس ـ درگیری فضای زیر زبانی

پاسخ: ج

۴۲ـ نمای Bull neck به چه علت ایجاد می‌شود؟

الف) انتشار عفونت به فضای تحت فکی در آنژین لودویگ

ب) انتشار عفونت به فضای زیر زبانی و فضای حلقی طرفی در ترومبوز سینوس کاورنوس

ج) انتشار عفونت به فضای حلقی طرفی و پشت حلقی در آنژین لودویگ

د) انتشار عفونت به فضای تحت فکی در ترومبوز سینوس کاورنوس

پاسخ: الف

۴۳ـ درگیری کدام فضا در ترومبوز سینوس کاورنوس دیده نمی‌شود؟

الف) فضای کانین ب) فضای باکال

ج) فضای اینفراتمپورال د) فضای زیر زبانی

پاسخ: د

۴۴ـ در درمان آنژین لودویگ اولویت نخست کدام است؟

الف) حذف کانون عفونت

ب) آنتی بیوتیک تراپی

ج) اینسیژن و درناژ

د) باز نگه داشتن راه هوایی

پاسخ: د

۴۵ـ علت استئومیلیت چرکی در کشورهای توسعه یافته اکثراً چه می‌باشد؟

الف) عفونت ادنتوژنیک ب) شکستگی فک

ج) ANUG د) الف و ب

پاسخ: د

۴۶ـ کدام یک جزء عوامل مستعدکننده استئومیلیت چرکی نمی‌باشد؟

الف) آنمی سلول داسی

ب) پاژت

ج) سمنتو اسئوس دیس پلازی

د) استئوپروزیس

پاسخ: د

مصرف تنباکو، الکل، مواد مخدر وریدی، دیابت، تب اگزانتماتوز، مالاریا، آنمی سلول داسی، سوء تغذیه، بدخیمی، بیماری کلاژن واسکولار، ایدز، پرتوتابی، استئوپتروز، دیس استئواسکلروز، پاژت و سمنتواسئوس دیس پلازی از عوامل مستعدکننده استئومیلیت چرکی‌اند.

۴۷ـ کدام گزینه از عوامل مستعدکننده درگیری فک بالا در استئومیلیت نمی‌باشد؟

الف) سن کم ب) ANUG

ج) نوما د) جنس مذکر

پاسخ: د

۴۸ـ مشاهده نواحی رادیولوسنت ragged و patchy با حدود نامشخص همراه با سکسترهای رادیواپک در مرکز ضایعه به نفع کدام نوع استئومیلیت می‌باشد؟

الف) Chronic suppurative osteomyelitis

ب) Diffuse Sclerosing osteomyelitis

ج) Acute Suppurative osteomyelitis

د) Focal Sclerosing osteomyelitis

پاسخ: الف

در استئومیلیت حاد چرکی ممکن است تغییرات رادیوگرافی مشاهده نشود و یا لوسنسی با حدود نامشخص دیده شود. در استئومیلیت اسکلروزه منتشر افزایش رادیودنسیتی در نواحی با التهاب مزمن مثل پریودنتیت یا بیماری التهابی پری اپیکال

CamScanner

دیده می‌شود و اسکلروز در قسمت کرست ریج آلوئل متمرکز است. در استئومیلیت اسکلروز شونده کانونی افزایش رادیودانسیته در مجاورت اپکس دندان دارای پالپیت و یا نکروتیک مشاهده می‌شود.

۴۹- کدام مورد در نمای میکروسکوپی استئومیلیت حاد چرکی دیده نمی‌شود؟

الف) مشاهده لاکوناهای فاقد استئوسیت

ب) تحلیل محیطی استخوان

ج) مشاهده کلونی‌های باکتریال

د) بافت همبندی فیبروزه التهابی

پاسخ: د

مشاهده بافت همبند فیبروزه التهابی بین ترابکولهای استخوانی از خصوصیات استئومیلیت مزمن چرکی است.

۵۰ـ کدام نوع استئومیلیت می‌تواند با سمنتواسئوس دیس پلازی فلوراید و بیماری پاژت اشتباه شود؟

الف) استئومیلیت اسکلروزه شونده منتشر

ب) استئومیلیت اسکلروزه شونده کانونی

ج) استئومیلیت گاره

د) استئومیلیت چرکی مزمن

پاسخ: الف

۵۱ـ در کدام مورد تجمع چرک و سکستر دیده نمی‌شود؟

الف) استئومیلیت مزمن اولیه

ب) استئومیلیت مزمن ثانویه

ج) تاندو پریوستیت مزمن

د) الف و ج

پاسخ: د

در استئومیلیت مزمن ثانویه (چرکی) تجمع چرک و سکستر دیده می‌شود.

۵۲ـ در کدام گزینه کشت میکروبی مثبت می‌شود؟

الف) استئومیلیت مزمن اولیه

ب) استئومیلیت اسکلروز شونده منتشر

ج) تاندوپریوستیت مزمن

د) سندرم SAPHO

پاسخ: ب

در استئومیلیت مزمن اولیه، تاندوپریوستیت مزمن و سندرم SAPHO و CRMO کشت میکروبی منفی می‌باشد.

۵۳- گزینه نادرست در مورد استئومیلیت اسکلروزه شونده منتشر کدام است؟

الف) در بالغین و در مندیبل شایعتر است.

ب) در اطراف یک ناحیه با التهاب مزمن مثل پریودنتیت یا پری کورونیت ایجاد می‌شود.

ج) معمولاً همراه درد و تورم می‌باشد.

د) کشت میکروبی در آن مثبت است.

پاسخ: ج

درد و تورم معمولاً در استئومیلیت اسکلروز شونده منتشر رخ نمی‌دهد.

۵۴ـ در مورد استئومیلیت مزمن اولیه گزینه نادرست کدام است؟

الف) نمای رادیوگرافی آن بصورت Medullary Sclerosis است.

ب) به آنتی بیوتیک تراپی پاسخ می‌دهد.

ج) دو بیماری SAPHO و CRMO تظاهراتی شبیه آن دارند.

د) در اتیولوژی آن پاسخ ایمنی متفاوت به یک ارگانیسم با ویرولانس پائین مطرح شده است.

پاسخ: ب

در استئومیلیت مزمن اولیه عفونت باکتریال وجود نداشته و تشکیل چرک و سکستر دیده نمی‌شود. کشت میکروبی آن منفی است و به آنتی بیوتیک جواب نمی‌دهد.

۵۵ـ درد راجعه و تورم گونه و تریسموس از مشخصات کدامیک می‌باشد؟

الف) SAPHO

ب) CRMO

ج) تندوپریوستیت مزمن

د) استئومیلیت اسکلروزه شونده منتشر

پاسخ: ج

تندوپریوستیت مزمن یک تغییر واکنشی در اثر استفاده زیاد از عضلات جونده است و کشت میکروبی آن منفی بوده و اسکلروزیس در آن در قسمت قدام و خلف مندیبل و محل اتصال عضلات دیگاستروماستر دیده می‌شود.

۵۶- گزینه نادرست در مورد Condensing Osteitis کدام است؟

الف) اکثراً در کودکان و بالغین جوان دیده می‌شود.

ب) محل شایع آن خلف مندیبل است.

ج) معمولاً همراه با اتساع کلینیکی است.

د) ۸۵٪ موارد آن پس از حذف کانون عفونت پسرفت خواهند کرد.

پاسخ: ج

اتساع کلینیکی در Condensing osteitis وجود ندارد.

۵۷ـ گزینه درست در مورد Condensing Osteitis کدام است؟

الف) همانند سمنتواسئوس دیس پلازی فوکال دارای حاشیه رادیولوسنت می‌باشد.

ب) معمولاً تورم قابل توجهی ایجاد می‌کند.

ج) برخلاف استئواسکلروز ایدیوپاتیک از اپکس دندان جدا نمی‌باشد.

د) به ناحیه باقیمانده پس از برطرف شدن کانون عفونت Fibrouse Scar می‌گویند.

پاسخ: ج

Condensing Osteitis بر خلاف سمنتواسئوس دیس پلازی کانونی حاشیه رادیولوسنت ندارد. تورم در این ضایعه دیده نمی‌شود. بر خلاف استئواسکلروز ایدیوپاتیک رادیواپسیتی از اپکس دندان جدا نیست. به ناحیه باقیمانده پس از برطرف شدن کانون عفونت Bone Scar می‌گویند.

۵۸ـ همه موارد زیر باعث تشکیل استخوان جدید پریوستئال می‌شوند بجز:

الف) Osteosarcoma

ب) Ewing Sarcoma

ج) Congenital syphillis

د) Avitaminosis D

پاسخ: د

استئومیلیت، تروما، سیست، هیپراستوزیس کورتیکال نوزادی، فلوروزیس، فقدان ویتامین C، هیپرتروفیک استئوآرتروپاتی، سارکوم یووینگ، استئوسارکوما، لانگرهانس سل هیستیوسیتوزیس و سفلیس مادرزادی از عوامل تشکیل استخوان جدید پریوستئال‌اند.

CamScanner

۵۹ـ در مورد Osteomyelitis with Proliferative periostitis گزینه صحیح کدام است؟

الف) بعد از حذف کانون عفونت، کانتور استخوان توسط جراحی بایستی اصلاح شود.

ب) در بررسی میکروسکوپی آن الگویی شبیه سمنتواسئوس دیس پلازی فوکال دیده می‌شود.

ج) بهترین رادیوگرافی جهت بررسی آن کلیشه‌های اکلوزالی است.

د) تیغه‌های استخوان واکنشی ایجاد شده در این ضایعه ۱ تا ۱۲ عدد بوده که بصورت موازی سطح قرار دارند.

پاسخ: د

استئومیلیت گاره اکثراً در اثر پوسیدگی در کودکان و افراد جوان دیده می‌شود که در آن لایه‌های متعددی از استخوان زنده (۱ تا ۱۲ عدد) بصورت موازی سطح کورتیکال ایجاد شده و باعث اتساع می‌شوند. در اغلب موارد خلف man محل درگیری است. بهترین گرافی جهت بررسی آن CT می‌باشد. در نمای میکروسکوپی لایه‌های موازی از استخوان نابالغ واکنشی و هیپر سلولار دیده می‌شود که گاهی الگویی شبیه فیبروز دیس پلازی نابالغ ایجاد کرده‌اند. معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه بعد از حذف کانون عفونت لایه‌های استخوان به کمک عضلات بهم می‌پیوندند.

۶۰ـ کدام گزینه در مورد Alveloar Osteitis صحیح می‌باشد؟

الف) مصرف بیحسی موضعی حاوی منقبض‌کننده عروقی از عوامل موثر در ایجاد آن است.

ب) برای درمان آن بعد از کورتاژ ساکت، پانسمان با اژنول گذاشته می‌شود.

ج) تتراسایکلین به شکل پماد معمولاً در درمان آن بکار گرفته می‌شود.

د) در خانم‌ها بطور شایعتری دیده می‌شود.

پاسخ: الف

Dry Socket معمولاً در خلف man و بدون تمایل جنسی خاصی دیده می‌شود. مصرف سیگار، داروی ضد بارداری، عفونت قبل از جراحی، کشیدن تروماتیک دندان، جراح بی تجربه، استفاده از بی‌حسی حاوی وازوکانستریکتور و شستشوی ناکافی بعد از جراحی در ایجاد آن نقش دارند. برای درمان آن کورتاژ و مصرف آنتی بیوتیک به شکل پماد (به علت ایجادمیو اسفرولوزیس) توصیه نمی‌شود.

۶۱ـ کدام مدیاتور عامل درد در Dry Socket می‌باشد؟ (ورودی ۹۳)

الف) نوروپپتید **ب) پروستاگلاندین**

ج) هیستامین **د) کینین‌ها**

پاسخ: د

۶۲ـ نمای میکروسکوپی پالپ پولیپ مشابه کدام یک از ضایعات زیر است؟ (ورودی ۹۴)

الف) ژانت سل فیبروما

ب) ژانت سل گرانولوما

ج) پیوژنیک گرانولوما

د) فیبروما‌ی تحریکی

پاسخ: ج

۶۳- شایعترین علت ایجاد Periostitis Ossificans چیست؟ (ورودی ۹۵)

الف) عفونت پریودنتال

ب) ترومای دندانی

ج) پوسیدگی دندانی

د) کیست فورکای باکال

پاسخ: ج

شایعترین علت استئومیلیت همراه پریوستیت پرولیفراتیو پوسیدگی دندانی می‌باشد.

۶۴ـ نمای هیستوپاتولوژی کدام یک از ضایعات زیر ممکن است شبیه فیبروز دیس پلازی نابالغ باشد؟ (بورد ۹۴)

الف) Condensing Osteitis

ب) Bone Scar

ج) Periostitis Ossificans

د) Alveolar Osteitis

پاسخ: ج

۶۵- دنتیکل پالپ به سبب کدام‌یک از عوامل زیر تشکیل می‌شود؟ (بورد ۹۲)

الف) القای اپی‌تلیوم مزانشیم در پالپ در حال تکامل

ب) ترومای وارد شده به پالپ

ج) تغییرات ناشی از افزایش سن پالپ

د) تغییرات ایجاد شده در جریان خون پالپ

پاسخ: الف

دنتیکل یکی از انواع کلسیفیکاسیون‌های پالپی است که علت ایجاد آن القای بین اپیتلیوم و مزانشیم در پالپ در حال تکامل است. اکثر انواع آن به عاج متصلند یا در آن مدفون شده‌اند.

۶۶- همه موارد زیر در ساختمان هیستولوژیک پری‌اپیکال گرانولوما می‌تواند دیده شود؛ بجز: (ارتقاء ۹۲)

الف) پایرونین بادی

ب) هیالین بادی

ج) ژانت‌سل چند هسته‌ای

د) راشتون بادی

پاسخ: د

راشتون بادی به کلسیفیکاسیون‌های خطی‌شکل در پوشش اپیتلیالی یک کیست پری‌اپیکال گفته می‌شود اما پیرونین‌بادی و راسل بادی هر دو محصول پلاسماسل‌ها هستند و در هر محلی با التهاب مزمن ممکن است دیده شوند. هیالین بادی نیز در واقع اگزودای التهابی می‌باشد که از عروق خارج شده سپس فیبروزه و کلسیفیه شده است و در هر محل التهاب مزمن ممکن است دیده شود.

۶۷- در کدام مورد نتیجه کشت میکروبی از ضایعات استخوانی مثبت است؟ (ارتقاء ۹۱)

الف) سندرم SAPHO

ب) تندوپریوستیت مزمن

ج) استئومیلیت اسکلروزه منتشر

د) استئیت کندانسه

پاسخ: ج

در استئومیلیت اسکلروزه شونده منتشر کشت میکروبی مثبت می‌شود اما در سه گزینه دیگر نتیجه کشت میکروبی منفی است.

۶۸- Periapical pocket cyst با کدام ویژگی مشخص می‌شود؟ (بورد ۹۰)

الف) کلسترول کلفت

ب) راسل بادی

ج) تجمع سلول‌های Foam

د) پوشش اپی‌تلیالی ناکامل

پاسخ: د

در کیست‌های پری‌اپیکال نوع pocket، چون قسمت اپیکال ریشه در داخل لومن کیست قرار گرفته است

CamScanner

پوشش کیست کامل نیست اما در کیست‌های true، کیست از ریشه دندان جداست در نتیجه پوشش آن یکدست و کامل است.

۶۹- تصویر میکروسکوپی کدام‌یک از انواع استئومیلیت مشابه فیبروز دیس‌پلازی می‌باشد؟ (بورد ۹۰)

الف) پریوستیت اسیفیکان

ب) استئومیلیت اسکلروزه منتشر

ج) استئومیلیت اولیه مزمن

د) استئیت کندانسه

پاسخ: الف

در پریوستیت اسیفیکان به‌علت اینکه استخوان سلولار نابالغ حضور دارد، الگوی میکروسکوپی ایجاد شده شبیه فیبروزدیس پلازیا است.

۷۰- فیبرودنتین چیست؟ (بورد ۸۸)

الف) لایه‌های اولیه عاج اولیه

ب) لایه‌های عاج ثانویه ساخته شده

ج) لایه‌های ابتدایی عاج ترمیمی

د) عاج گلبولار

پاسخ: ج

فیبرودنتین (یا interface dentin) به اولین لایه‌های عاج ترمیمی گفته می‌شود. فیبرودنتین آتوبولار است.

۷۱- کدام‌یک از عبارات زیر در مورد Pariapical pocket cyst درست است؟

الف) ویژگی‌های این ضایعه کاملاً مشابه True periapical cyst است.

ب) نوعی کیست پری‌اپیکال با پوشش ناکامل به دلیل نفوذ ریشه به داخل لومن است.

ج) ارتباطی به کیست پری‌اپیکال نداشته و یک کیست ادنتوژنیک تکاملی است.

د) در ناحیه اپیکال پاکت پریودنتال در دندان‌های نکروزه ایجاد می‌شود.

پاسخ: ب

۷۲- در کدام‌یک از موارد زیر کشت میکروبی مثبت می‌شود؟ (ورودی ۸۶)

الف) استئومیلیت اسکلروزه منتشر

ب) تندوپریوستیت مزمن

ج) سندرم SAPHO

د) استئومیلیت اسکلروزه کانونی

پاسخ: الف

در صورت کشت میکروبی در استئومیلیت اسکلروزه منتشر، پاسخ کشت مثبت است؛ اما در تندوپریوستیت مزمن و استئومیلیت مزمن اولیه و سندرم SAPHO و CRMO، پاسخ کشت میکروبی منفی است.

۷۳- در تصویر میکروسکوپی گرانولوم پری‌اپیکال تمام موارد زیر قابل رؤیت است؛ بجز: (ورودی ۸۸)

الف) اجسام راشتون

ب) اجسام راسل

ج) بقایای اپی‌تلیال ادنتوژن

د) اجسام پیرونین

پاسخ: الف

گرانولوم پری‌اپیکال یک بافت گرانولیشن متشکل از لنفوسیت‌ها و سایر سلول‌های التهابی می‌باشد. راسل بادی (اجسام ائوزینوفیل متشکل از گاماگلوبولین‌ها) و پیرونین بادی (اجسام بازوفیل) که هردو از محصولات پلاسماسل‌ها می‌باشند نیز در هر محلی با عفونت

مزمن مشاهده می‌شوند. بقایای اپیتلیوم ادنتوژن و شکاف کلسترول هم در گرانولوم دیده می‌شوند. راشتون بادی مربوط به پوشش اپیتلیالی کیست رادیکولر می‌باشد.

۷۴- پالپیت هیپرپلاستیک مزمن از نظر هیستوپاتولوژی مشابه کدام‌یک از ضایعات زیر است؟(ورودی ۹۰)

الف) پیوژنیک گرانولوما

ب) فیبروم تحریکی

ج) ژانت‌سل گرانولوما

د) ژانت‌سل فیبروما

پاسخ: الف

یک بافت جوانه‌ای (مشابه پیوژنیک گرانولوما) در پالپیت هیپرپلاستیک مزمن (پولیپ پالپ) دیده می‌شود. پولیپ پالپ در سطح با اپیتلیوم سنگفرشی مطبق پوشیده می‌شود.

۷۵- همه افراد زیر مستعد ابتلا به Dry socket هستند؛ بجز: (ورودی ۹۲)

الف) مصرف‌کنندگان قرص‌های ضد بارداری

ب) سیگاری‌ها

ج) افراد مبتلا به آنمی فقر آهن

د) افراد مبتلا به پری‌کورونیت علامت‌دار

پاسخ: ج

علاوه بر موارد ذکر شده، خارج کردن دندان همراه با تروما نیز از عوامل مستعد کننده ابتلا به Dry socket می‌باشد.

۷۶- بیشترین سلولی که در نمای هیستوپاتولوژی دنتال گرانولوما دیده می‌شود عبارتست از:(ورودی ۹۱)

الف) ژانت‌سل **ب) ماست‌سل**

ج) ائوزینوفیل **د) لنفوسیت**

پاسخ: د

۷۷- منشاء اپی‌تلیوم پوشاننده Pulp polyp کدام‌یک از موارد زیر است؟ (ورودی ۸۷)

الف) بقایای دنتال لامینا

ب) بقایای انامل ارگان

ج) اپی‌تلیوم پوشاننده حفره دهان

د) بقایای مالاسز

پاسخ: ج

پولیپ پالپ نام دیگر پالپیت هیپرپلاستیک مزمن می‌باشد که در آن یک گرانولیشن تیشو تمام فضای پالپ چمبر را پر کرده است. پولیپ پالپ در سطح با اپیتلیوم سنگفرشی مطبق پوشیده شده که منشأ آن، اپیتلیوم پوشاننده حفره دهان (مربوط به لثه یا از اپیتلیوم متفلس شده) است.

۷۸- کدام‌یک از انواع کلسیفیکاسیون‌های پالپی زیر در نتیجه عمل متقابل اپی‌تلیوم و مزانشیم به وجود می‌آید؟ (ورودی ۸۳)

الف) دنتیکل

ب) سنگ‌های پالپی

ج) کلسیفیکاسیون‌های خطی منتشر

د)کلسیفیکاسیون‌های منتشر دور عصب

پاسخ: الف

سه نوع کلسیفیکاسیون پالپی وجود دارد: دنتیکل، سنگ پالپی و کلسیفیکاسیون منتشر اطراف عروق و اعصاب به‌صورت خطی. از بین این‌ها، دنتیکل‌ها در اثر واکنش متقابل بین اپیتلیوم و مزانشیم در هنگام تکامل پالپ ایجاد می‌شوند.

CamScanner